

TEMA 3.43 • OBSTETRICIA

Parto Vaginal

PERFIL EUNACOM 2.01.2.027
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Parto Vaginal

Indicaciones de Cesárea

TABLA 3.43.1: INDICACIÓN VS DETALLE	
INDICACIÓN	DETALLE
Cesárea previa	2 cesáreas segmentarias; o 1 corporal; o 1 segmentaria < 12 meses; o 1 si hay necesidad de misoprostol
Presentación podálica o transversa	
Presentación de frente	Cefálica deflectada, no tiene opción de parto vaginal
Presentación de cara	Excepto mento-anterior (mento-púbica)
Desproporción cefalopélvica (DCP)	= prueba de parto fracasada
Placenta previa oclusiva total	(la marginal y parcial tienen opción vaginal)
Macrosomía ≥ 4.500 g	(en diabética desde ≥ 4.200 g)
Herpes genital activo	
Cáncer de cuello uterino	Riesgo de diseminación
Tumor previo grande	(condiloma acuminado NO contraindica, salvo si es gigante)
Prematurez < 28 sem / < 1 kg	Indicación relativa
Vía expedita urgente	Sufrimiento fetal, DPPNI, corioamnionitis, eclampsia → indicación de interrupción rápida (cesárea si el parto no está avanzado)

Fases del Parto

Fase de dilatación

TABLA 3.43.2: FASE VS LÍMITES	
FASE	LÍMITES
Latente	Inicio de modificaciones cervicales → 3 cm
Activa	4 cm → 10 cm

Fase de expulsivo

10 cm → nacimiento del recién nacido.

Alumbramiento

Nacimiento → expulsión de placenta.

Duración Normal de las Fases

TABLA 3.43.3: FASE VS MULTÍPARA		
FASE	MULTÍPARA	PRIMIGESTA
Latente	Hasta 14 horas	Hasta 20 horas
Activa	≥ 1,5 cm/hora	≥ 1 cm/hora
Expulsivo	Hasta 1 hora (2h con anestesia)	Hasta 2 horas (3h con anestesia)
Alumbramiento	< 30 min	< 45 min

Manejo según Fase al Llegar

TABLA 3.43.4: FASE AL LLEGAR VS CONDUCTA	
FASE AL LLEGAR	CONDUCTA
Latente	Enviar a domicilio (reconsultar si rompe bolsa, sangra o dolor intenso). Pedir RBNS previo al alta.
Activa	Hospitalizar en sala de parto
Expulsivo	Hospitalizar de inmediato

Prueba de Trabajo de Parto (Prueba de Parto)

Indicación: Sospecha de desproporción cefalopélvica = parto que **no avanza** en la fase activa.

Positiva (parto progresa) → continuar vía vaginal. **Negativa** (parto no avanza tras conducción) → **DCP** → **cesárea**.

Elementos de conducción del trabajo de parto

- Oxitocina** en goteo: objetivo → 3–5 contracciones en 10 minutos. No usar si la dinámica ya es buena (3–5 cx/10 min).
- Rotura artificial de membranas (RAM):** si membranas íntegras.
- Anestesia** (raquídea/peridural): es un **derecho** de la paciente; indicación = dolor (no el parto en sí). Se puede administrar incluso en parto que avanza bien.

NOTA CLÍNICA

Decúbito lateral izquierdo durante la prueba de parto (mejora perfusión útero-placentaria).

Planos de Hodge (descenso fetal)

TABLA 3.43.5: PLANO VS REFERENCIA		
PLANO	REFERENCIA	NIVEL
Plano I	Espina - 4	Alto
Plano II	Espina - 2	
Plano III (línea de espinas)	Espina 0	
Plano IV	Espina +2	Bajo — inminente
Plano V	Espina +4	Nacimiento inminente

(Cada 2 cm = 1 plano de Hodge)

Casos Prácticos Tipo EUNACOM

TABLA 3.43.6: EG VS DINÁMICA						CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM
EG	DINÁMICA	PLANO/ESPINA	DILAT.	MEMBRANAS	TIEMPO SIN CAMBIO	CONDUCTA
Cefálica	4/10 min (buena)	espina +2	5 cm activa	íntegras	2h sin cambio	ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO: "En relación a Parto Vaginal: DCP) = prueba de parto fracasada Placenta previa oclusiva total (la marg... ¿cuál es la conducta correcta?" EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA: Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Parto Vaginal. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea. PUNTOS CLAVE DESTACADOS - Fases del Parto - Fase de dilatación espontánea - Fase de expulsivo - Alumbramiento - Duración Normal de las Fases - Manejo según Fase al Llegar
Cefálica	2/10 min (pobre)	espina 0	7 cm activa	rotas	2h sin cambio	
Cefálica	4/10 min (buena)	—	10 cm expulsivo	rotas	2h sin cambio	
Cefálica	2/10 min	espina -2	5 cm activa	íntegras	Acaba de llegar	

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PARTO VAGINAL)

PREGUNTA 1

En relación a Parto Vaginal: DCP) | = prueba de parto fracasada | | Placenta previa oclusiva total | (la marg... ¿cuál es la conducta correcta?

A) El diagnóstico de Parto Vaginal se basa exclusivamente en criterios de laboratorio

B) El manejo inicial de Parto Vaginal debe orientarse según el estado clínico del paciente

C) Todo paciente con Parto Vaginal requiere hospitalización inmediata

D) El tratamiento de Parto Vaginal es igual en todas las edades y contextos clínicos

E) El seguimiento de Parto Vaginal no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Parto Vaginal?

A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas

B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM

C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico

D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero

E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Parto Vaginal. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada

B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos

C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología

D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización

E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: PARTO VAGINAL

Positiva (parto progresa) → continuar vía vaginal. Negativa (parto no avanza tras conducción) → DCP → cesárea. 1. Oxitocina en goteo: objetivo → 3–5 contracciones en 10 minutos. No usar si la dinámica ya es buena (3–5 cx/10 min). 2. Rotura artificial de membranas (RAM): si membranas íntegras. 3. Anestesia (raquídea/peridural): es un derecho de la paciente; indicación = dolor (no el parto en sí). Se puede administrar incluso en parto que avanza bien. :::note Decúbito lateral izquierdo durante la prueba de parto (mejora perfusión útero-placentaria). :::